

Teams Bouch 2

(0:04 - 0:39)

Est-ce que vous m'entendez? C'est quoi la primo-infection tuberculose? La primo-infection tuberculose ou on l'appelle également tuberculose infection. La primo-infection tuberculose c'est l'ensemble des manifestations immunologiques, cliniques ou radiologiques au rapport avec un premier contact du corps avec le BK, du poumon avec le BK. C'est ça la primo-infection tuberculose.

(0:41 - 0:55)

Donc, lors du premier contact avec le BK. Oui, oui, Marwa, c'est bien. Donc c'est souvent des manifestations immunologiques en premier, peut-être cliniques et peut-être radiologiques.

(0:55 - 1:03)

Mais les manifestations surtout immunologiques. J'insiste sur ce terme immunologique. Il faut cocher ce terme immunologique.

(1:04 - 1:25)

Deuxième question, quelles sont les formes de primo-infection? Il y a deux formes de primo-infection. Il y a deux formes. Quelles sont ces deux formes? Il y a deux formes de primo-infection.

(1:26 - 1:43)

Il y a une primo-infection et l'autre primo-infection. C'est quoi votre réponse? Les primo-infections connues. Il y a la primo-infection latente et la primo-infection patente.

(1:43 - 2:08)

Donc, il y a la primo infection latente et la primo infection patente. C'est correct. La deuxième, quelle est la plus fréquente des deux? Quelle est la forme la plus fréquente des deux? La latente ou la patente? La plus fréquente, c'est la latente.

(2:08 - 2:15)

C'est 90%. Pratiquement 90%. La primo infection tuberculeuse, il est latente.

(2:15 - 2:57)

Donc, la forme clinique du primo infection la plus fréquente, c'est la forme latente. Au Maroc, chez qui on voit la primo infection tuberculeuse? Est-ce qu'on la voit chez l'enfant ou chez l'adulte? La primo infection tuberculeuse chez l'homme, est-ce qu'on la voit au Maroc chez

l'enfant? Et si on était un pays développé, qu'elle sera, elle touche qui? Par exemple, au pays scandinave, au Danemark, au Canada, je ne sais pas, c'est plus l'adulte, l'adulte âgé. C'est le sujet âgé.

(2:59 - 3:10)

Il y a l'adulte qui est en état de santé, il est sujet âgé. Mais au Maroc, la primo infection touche surtout l'enfant. Surtout l'enfant.

(3:12 - 3:22)

Donc, on rappelle qu'il y a deux formes de primo infection. La primo infection latente la plus fréquente. La primo infection patente avec des manifestations cliniques.

(3:23 - 3:40)

Et au Maroc, la primo infection tuberculeuse touche essentiellement l'enfant. Donc, dans la primo infection, vous avez un premier contact du BK avec le corps. Il va être à l'origine d'un complexe primaire.

(3:41 - 3:59)

Par quoi est constitué ce complexe primaire? Le complexe primaire dans la primo infection. On parle de primo infection patente, surtout. Le complexe primaire est composé par quoi? Par deux atteintes d'organes différents.

(4:01 - 4:22)

Par ce qu'on appelle, ce qu'on appelle. Donc, le complexe primaire, il est formé par quoi? Par le chancre d'onucléation et l'adénopathie satellite. Donc, la primo infection patente, on aura des manifestations cliniques et radiologiques.

(4:22 - 4:37)

Et parmi les manifestations radiologiques, on a ce qu'on appelle le complexe primaire qui est formé par le chancre d'onucléation et l'adénopathie satellite. Bravo, on a suivi bien. Donc, nous avons ces questions.

(4:40 - 5:02)

La forme patente, est ce que c'est la forme la plus fréquente? Est ce qu'il est souvent symptomatique? Plutôt la primo infection latente. Est ce que c'est la forme la plus fréquente? Est ce qu'il est souvent symptomatique? Tout, surtout l'adulte au Maroc. Peut être révélé par un érythème nouveau.

(5:02 - 5:16)

La radiographie thoracique est normale. Quel, quel, quel éthème vous avez coché? Quelle réponse vous avez coché? La primo infection latente est la forme la plus fréquente. Souvent symptomatique.

(5:17 - 5:25)

Touche surtout l'adulte au Maroc. Peut être révélé par un érythème nouveau. La radiographie thoracique est anormale.

(5:33 - 6:00)

Le A, le B, le C, le D, le E. Le complexe primaire, on le voit surtout dans les formes patentées. Dans les formes patentées. Les anomalies cliniques ou radiologiques, on les voit surtout dans les formes patentées.

(6:04 - 6:20)

Le A, vous avez une seule réponse. Donc la primo infection latente est la forme la plus fréquente parce qu'il représente 90%. Elle est souvent asymptomatique.

(6:20 - 6:28)

Elle est souvent asymptomatique. Et touche surtout l'enfant au Maroc. Il peut être révélé par un érythème nouveau.

(6:29 - 6:36)

C'est la primo infection patente. Les signes cliniques, vous avez la patente. La radiographie thoracique, elle est normale.

(6:37 - 7:08)

Donc vous avez la réponse A. C'est la réponse A. Donc on revient pour la primo infection patente. Est-ce que c'est la forme la plus fréquente? Est-ce qu'il peut réaliser un tableau qui va simuler la fièvre typhoïde? Ce qu'on appelle un tableau de pseudotypique de l'endosie. Est-ce qu'il peut être une chato-conjonctivite? Peut-être un signe révélateur.

(7:09 - 7:33)

La primo infection patente peut être découverte radiologique. Est-ce qu'il est souvent asymptomatique? La primo infection patente, est-ce qu'il est fréquente? Est-ce qu'il réalise un tableau pseudotypique? La chato-conjonctivite est un signe révélateur. Il peut être découverte radiologique.

(7:33 - 7:50)

Il est souvent asymptomatique. Donc quelles réponses vous avez? Les réponses que vous avez? Oui, Marois, oui, Menel, oui. Quoi d'autre? Oui.

(7:51 - 8:23)

Donc, c'est le BLCD, donc si on en fait. La primo infection, elle est moins fréquente que la primo infection latente. Il réalise un tableau aigu qui représente un tableau pseudotypique de l'endosie avec de la fièvre, des douleurs, des troubles digestifs, mais on n'avait pas la dissociation pour et fièvre et la langue n'est pas chargée et la sérologie de la fièvre et des troubles fluides est négative.

(8:24 - 8:42)

Et les d'autres qui sont évocateurs, il y a deux. La chiato-conjonctivite flectinulaire et l'irritem nouveau dans la forme primo infection patente. L'irritem nouveau et la chiato-conjonctivite sont des signes évocateurs et traduits des phénomènes émino-allergiques.

(8:43 - 8:52)

On va dire traduits émino-allergiques. La primo infection et la tuberculose maladie, c'est autre chose. La tuberculose maladie, c'est autre chose.

(8:52 - 9:08)

La primo infection, c'est un premier contact de BK avec l'organisme. Donc, ce sont surtout des manifestations éminologiques, cliniques et radiologiques après. Après, on va voir la tuberculose maladie.

(9:08 - 9:23)

On va faire une synthèse de la primo infection, de la tuberculose maladie, de la tuberculose aiguë. On va faire un tour de table et pour bien comprendre. Donc, si vous parlez de primo infection patente, elle est moins fréquente.

(9:23 - 9:42)

Elle représente 10%. Elle peut réaliser un syndrome qui peut simuler la fièvre typhoïde, un syndrome pseudotypique, oui. Des phénomènes émino-allergiques comme l'irritem nouveau et la chiato-conjonctivite flectinulaire est très évocatrice de la primo infection patente.

(9:42 - 9:58)

Elle peut être de découverte radiologique. Donc, la radio est anormale en cas de primo infection patente. Elle est souvent symptomatique, contrairement à la primo infection latente.

(9:58 - 10:14)

Est-ce que vous avez des questions jusque là? Est-ce que vous avez des questions? Il faut bien se concentrer sur ce que je dis. Ce sont des mots, j'insiste de le dire. Il faut bien, bien, bien se concentrer et bien retenir ce que je dis.

(10:15 - 10:38)

Voici le complexe primaire. Le complexe primaire, il est formé par ici, par le champ d'inoculation ici en bas et par les aides à neuropathie. Voyez que le champ d'inoculation n'a pas de sièges particuliers, contrairement à la tuberculose ou les lésions qui siègent au niveau des semelles.

(10:38 - 10:45)

Voici le champ d'inoculation. Vous avez un champ d'inoculation avec des aides à neuropathie. Il est ici comme ça.

(10:46 - 11:09)

Et là, le champ et l'aide à neuropathie constituent ce qu'on appelle le complexe primaire. Donc, le complexe primaire est constitué par le champ d'inoculation associé à des aides à neuropathie satellites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner pour que je vous réponde au fur et à mesure.

(11:13 - 11:37)

Voici sur le plan radiologique plus sophistiqué, c'est-à-dire sur les scanners, parce que les lésions en primo-infection, rarement qu'on les voit, on les voit surtout sur les scanners. Vous voyez ce champ d'inoculation. Le champ d'inoculation, celui-là.

(11:40 - 11:47)

Vous voyez ce champ d'inoculation. Et vous avez ces adénopathies avec une écrosse centrale. Vous avez ce champ noir.

(11:47 - 12:11)

C'est une écrosse centrale. Donc, on va passer aux prochaines. Lorsqu'on parle de la primo-infection tuberculeuse, vous devez ressortir le terme intradermoréaction à la tuberculine.

(12:13 - 12:33)

Intradermoréaction à la tuberculine. Donc, la primo-infection, son diagnostic se fait par l'intradermoréaction à la tuberculine. Donc, lorsque vous voyez chapitre d'intradermoréaction de primo-infection, c'est l'intradermoréaction à la tuberculine.

(12:33 - 12:45)

Il y a des tests de production de l'interferon gamma. Ce sont des tests qui ont pratiquement l'équivalent de l'intradermoréaction à la tuberculine. Il permet de doser ou de rechercher l'interferon gamma produit par les cellules mononucléaires.

(12:46 - 13:04)

Donc, comment réaliser une intradermoréaction à la tuberculine ? C'est très facile. C'est avoir 0,1 millilitre de la solution, une seringue à la face antérieure de l'avant-bras et vous avez une lecture 72 heures. Vous recherchez quoi ? Par l'intradermoréaction à la tuberculine.

(13:05 - 13:33)

Qu'est-ce que vous cherchez par l'intradermoréaction à la tuberculine ? Qu'est-ce qui vous permet de chercher ? Qu'est-ce qui vous permet de chercher l'intradermoréaction à la tuberculine ? Lorsque vous réalisez l'intradermoréaction, vous cherchez quelque chose. C'est quoi ce qui est enrougé ? On va mesurer cette induration. Oui, c'est la masse, c'est bravo.

(13:34 - 13:47)

L'hypersensibilité retardée. On cherche l'hypersensibilité retardée et la lecture se fait à 72 heures. Vous devez attendre 72 heures pour avoir le résultat.

(13:47 - 14:08)

Est-ce que les valeurs de la positivité de l'intradermoréaction au Maroc sont équivalentes à celles en France, par exemple ? Les valeurs. En France, c'est supérieur à 5 mm. Au Maroc, c'est supérieur ou égal à 6 mm.

(14:08 - 14:22)

Donc au Maroc, c'est supérieur. Vous dites qu'une intradermoréaction tuberculose est positive lorsqu'elle est supérieure ou égale à 6 mm. Vous ne mesurez pas la rougeur, vous avez l'induration.

(14:22 - 14:29)

C'est l'induration au sens. C'est ça que vous allez mesurer. Ce n'est pas la rougeur du ritamone 1. Vous avez cette papule que vous avez mesurée.

(14:30 - 15:06)

Lorsque vous réalisez l'intradermoréaction, vous attendez un résultat. Vous allez répondre si c'est une intradermoréaction positive ou si c'est une intradermoréaction négative. Si elle est

supérieure ou égale à 6 mm et qu'elle est positive, est-ce qu'elle est inférieure à 6 mm si c'est négative ? Dans quelles sont les situations où l'intradermoréaction est positive ? Quelle situation ? L'intradermoréaction à la tuberculose est positive.

(15:07 - 15:18)

Elle est supérieure ou égale à 6 mm. Contacts avec le BK, oui. La tuberculose, maladie, oui.

(15:20 - 15:37)

Il vous reste autre chose, c'est quoi ? Contacts avec le BK, la vaccination BCG. Donc, c'est trois situations cliniques. Si vous êtes vacciné par le BCG, vous avez une intradermoréaction qui est positive.

(15:37 - 15:54)

Nous sommes dans l'interrogatoire. On va rechercher, en interprétant les résultats, on va demander est-ce que vous êtes vacciné ou non par le BCG. Est-ce que vous avez un contact ou vous avez la tuberculose, maladie ? Et parfois, il y a des erreurs techniques pour ce qui est de l'injection.

(15:54 - 16:14)

Une grande dose de la tuberculose, l'injection n'est pas intradermique, qui donne des réactions qui sont un peu mieux. Ce ne sont que des erreurs techniques, mais cliniquement, c'est ça. Contacts avec le BK, soit une primo-infection, soit une tuberculose, maladie, ou soit vacciné par le BCG.

(16:15 - 16:43)

Et la deuxième chose, dans quelle situation l'intradermoréaction est négative ? L'intradermoréaction est négative. Parfois, vous réalisez une intradermoréaction, vous faites une lecture à 62 heures et vous trouvez que l'intradermoréaction est négative. Dans quelle situation votre intradermoréaction est négative ? Une situation où l'intradermoréaction est négative.

(16:44 - 16:56)

Dans le cas de tuberculose aiguë, absence de contacts, oui. Quoi d'autre ? Pas de vaccination. HIV, oui.

(17:02 - 17:38)

Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Chirurgicothérapie, immunodépression, hémopathie maligne. Donc, l'intradermoréaction, défaut négatif. L'intradermoréaction tuberculaire, la première chose, négative, c'est-à-dire que vous êtes sain.

(17:39 - 17:48)

Négatif, vous n'êtes pas malade. Vous n'avez jamais eu de contacts avec le BK. Donc, le sujet sain, l'intradermoréaction est négative.

(17:48 - 17:58)

Vous n'avez jamais eu de contacts avec le BK, donc l'intradermoréaction est négative. C'est la première situation. La deuxième, c'est quelqu'un qui n'est pas vacciné par le BCG.

(17:59 - 18:15)

Qui n'est pas vacciné par le BCG. La troisième, lorsqu'on est en phase antiallergique. Vous savez, lorsqu'on fait une intradermo, c'est négatif, on doit la refaire entre 12 à 16 semaines.

(18:15 - 18:27)

C'est-à-dire, pratiquement, entre 3 mois. Parfois, lorsqu'on fait l'intradermoréaction négative, on veut voir est-ce que c'est vraiment négatif ou non. On va faire l'intradermo, la refaire à 3 mois.

(18:27 - 18:36)

La 3 mois, c'est la phase antiallergique. Si vous la faites dans cette phase antiallergique, l'intradermo est négatif. L'intradermo est négatif.

(18:36 - 18:45)

Donc, dans les 2 semaines, souvent, le contact, c'est ça. Pour cela, il faut attendre plus de 12 semaines. Pour le négatif, c'est à coup ou à dose.

(18:46 - 18:56)

Pour vous résumer les choses, l'intradermoréaction négative, c'est banal. Vous n'avez pas de contact avec le BK, donc l'intradermo est négatif. Vous êtes un sujet normal, sain, vous n'êtes pas malade.

(18:57 - 19:12)

La deuxième, est-ce que vous êtes vacciné? Apparemment, vous n'êtes pas vacciné par le BCG. Si vous êtes vacciné par le BCG, l'intradermoréaction, ce sera positif. Soit vous êtes infecté, mais vous êtes en phase antiallergique.

(19:12 - 19:29)

Même si vous avez l'intradermo négatif, vous devez attendre 12 semaines. Donc, c'est la phase antiallergique ou vous êtes immunodéprimé. L'hémopathie maligne, les corticothérapies, les

immunosuppresseurs, les VIH, c'est l'immunodépression.

(19:29 - 19:54)

L'immunodépression, l'intradermoréaction, l'intradermoréaction à la tuberculine, elle est négative chez les sujets immunodéprimés. Pourquoi elle est négative chez les immunodéprimés? Comment vous expliquez ça? Que l'intradermoréaction est négative, non, chez les immunodéprimés. L'intradermo, elle est négative chez les immunodéprimés.

(20:00 - 1:09:55)

L'intradermo, elle est négative chez les immunodéprimés. Pourquoi? Par quel mécanisme? Tous les sujets, tous les sujets. des huit et que ce leur interaction entre ces cellules qui à l'origine de production de médiateurs de chimie aucune qu'on appelle le TNF alpha ou l'interférent gamma pour constituer un granulome et réaction allergique donc les immunodéprimés l'intradermoréaction est négative donc tous les patients immunodéprimés vous avez une réaction négative donc l'intradermoréaction est négative sujet sans absence de vaccination par le BCG et immunodépressions pour ce qui est de la tuberculose aiguë parce que la tuberculose aiguë c'est une forme grave et parce que la tuberculose il survient sur un sujet immunodéprimé c'est pourquoi dans la situation de tuberculose aiguë vous avez de l'intradermoréaction qui est négative parce que la tuberculose aiguë survient sur un terrain immunodéprimé la première chose que vous allez voir l'intradermoréaction c'est l'absence de contact c'est l'absence de vaccination et surtout rechercher un déficit immunitaire un déficit immunitaire dans toutes les situations qui donnent un déficit immunitaire surtout cellulaire vont donner une intradermoréaction qui est négative quand tu couvres dans l'encore à l'encore les immunosuppresseurs l'encore le VIH encore et parce que vous avez répondu la tuberculose aiguë c'est une bonne réponse mais vous expliquer que la tuberculose aiguë survient sur un terrain et immunodéprime c'est sa situation c'est l'immunodépression qui est responsable de cette intradermoréaction qui est négative donc on va capituler une intradermoréaction positive devant un contact avec le bacille de Coq qui peut être soit au cours d'une primo infection tuberculose ou au cours d'une tuberculose maladie par la vaccination par le BCG et par défauts positifs ce sont des erreurs techniques on ne va pas citer et l'intradermoréaction négative c'est l'absence de contact ou l'absence de vaccination est ce que vous êtes en phase anti allergique ou vous êtes quelqu'un qui est immunodéprimé retenir ces éléments là intradermoréaction positif ou négatif dans cette situation il faut retenir ces items là pour l'intradermoréaction parce que la primo infection tuberculose on fait son diagnostic par les tests immunologiques par l'intradermoréaction lorsque vous parlez de la primo infection ou la tuberculose infection ça en parle directement de l'on va parler toujours de l'intradermoréaction et de ses résultats donc le diagnostic de la primo infection est ce qu'il est clinique est ce qu'il est bactériologique est ce qu'il est histologique est ce qu'il est basé sur le test immunologique est ce que par la clinique vous diagnostiquez une primo infection ou la positivité des BK vous dites que c'est une primo infection ou vous avez trouvé un granulome vous dites une prévention ou la primo infection est basée sur des tests immunologiques pour ce qui est de la vaccination de BK ce se

fait à la naissance elle protège pendant 10 ans surtout on le fait uniquement à la naissance et surtout dans les pays à grande incidence ou prévalence de tuberculose dans les pays développés par exemple la France on le fait moins n'est pas obligatoire la vaccination par le BCG on ne le répète pas et l'intérêt du BCG c'est pas que vous n'avez pas de tuberculose c'est la prévention de tuberculose grave qui sont la tuberculose méningée la tuberculose le but du BCG c'est protéger contre les formes graves de tuberculose vous êtes vacciné par le BCG vous pouvez faire une tuberculose on répète pas le BCG se fait uniquement à la naissance du BCG donc le diagnostic retenez le diagnostic est ce qu'il est clinique bactériologique histologique ou basé sur des tests immunologiques donc le diagnostic de la primo infection il est immunologique il est basé sur l'intradermo réaction à la tuberculose et par les tests de production de l'interférent gamma qu'on appelle le quantiférant vous allez entendre ce terme quantiférant quantiférant c'est quantifier l'interférent gamma qui est produit par les macrophages et par les lymphocytes CD8 donc la diagnostic de la tuberculose infection la primo infection tuberculose est basée sur les tests immunologiques donc on va passer pour le deuxième cas clinique deuxième cas clinique un jeune patient de 22 ans sans état pathologique particulier qui présente une pneumopathie il a fait une infection pulmonaire et pneumonie quand vous avez donné des antibiotiques pour une dizaine de jours certains jours c'est pas amélioré ce pour cela vous avez fait une radio donc on va voir d'écrire la radio qu'est ce que vous voyez à la radio l'image c'est ici c'est l'image ici c'est quoi qui vous attire à la radio à la radio vous avez cette image là cette image ici comment vous décrivez cette image comment vous décrivez cette image qu'est ce que vous trouvez d'anormal dans cette image l'image c'est ici l'image c'est à droite c'est ici c'est ici quelle image vous voyez donc vous voyez quelle image cette image comment vous décrivez cette image comment vous la décrivez opacité, clarté, siège, syndrome alvéolaire, opacité à piquet à droite avec un bon gramme AIR-X c'est bien mais il reste quelque chose très important c'est quoi c'est une opacité de type alvéolaire et à piquet à droite oui mais il reste quelque chose très important qui reste c'est quoi ça c'est quoi l'image cavitaire c'est une image cavitaire donc c'est une opacité il faut la localiser c'est pas le fait de dire une opacité droite à piquet à droite avec bon gramme AIR-X ou avec une caverne c'est la caverne c'est une image cavitaire c'est une image cavitaire image cavitaire donc vous évoquez une tuberculose pulmonaire commune sur quel sur quel critère vous évoquez une tuberculose radiologique c'est pas clinique l'adénopathie satellite non c'est pas une adénopathie satellite l'adénopathie on le voit surtout sur la primo-infection tuberculose la primo-infection il y a l'adénopathie et le chancre d'inoculation rarement qu'on trouve le chancre on trouve les adénopathies mais dans la tuberculose pulmonaire commune si tu t'atteints par enchimateur il faut rechercher la lésion au niveau du poumon au niveau du par enchimateur pulmonaire quels sont les éléments que vous en j'ai dit que c'est une pneumopathie qui n'est pas améliorée bactérienne qui n'est pas amélioré c'est pas bactérienne mais radiologiquement les éléments qui orientent que c'est une tuberculose probablement c'est une tuberculose qui oriente ça confirme pas les caractéristiques de l'image qui vous oriente vers une tuberculose c'est quoi l'image cavitaire oui la caverne la caverne tout d'abord la caverne quoi d'autre si vous avez ça vous évoquez une caverne oui quoi d'autre le

siège de l'image le siège le siège où apicale siège apical pour le chancre d'inoculation est ce qu'il a une localisation particulière pour l'après mois infection non peut être basale et peut être apicale mais dans la tuberculose maladie il est le siège apicale pourquoi apicale pourquoi apicale pourquoi apicale je parle de la tuberculose pulmonaire commune pourquoi les lésions prédominent au niveau des apex pourquoi les lésions de la tuberculose vous voulez chercher si vous avez une tuberculose vous faites la radio donc vous regardez les sommets pourquoi les sommets prétoire mieux ventilé mieux ventilé oui quoi d'autre mieux ventilé un rapport ventilation c'est variable mieux ventilé parce qu'il y a de l'oxygène de l'oxygène et le bk c'est un germe aérobic strict aérobic strict pourquoi le sommet parce qu'il y a plus d'oxygène et le bk c'est un germe aérobic strict il a besoin de l'oxygène et lorsqu'on a les oxygènes très élevés on a la capacité des macrophages à détruire appartement à phagocyter le bk diminue leur activité bactéricide diminue c'est pourquoi dans la tuberculose lorsque vous cherchez ou vous êtes orienté par des signes de tuberculose vous cherchez les lésions au niveau des sommets parce qu'ils sont les mieux ventilés parce que le bk est un germe aérobic strict et parce que la pression qui est très élevée d'oxygène au niveau va déprimer le système immunitaire formé par les macrophages donc on n'a plus de macrophages, on n'a plus de pouvoir bactéricide pour confirmer votre diagnostic je parle bilan pour confirmer est ce que vous faites une intradermoréaction à la tuberculine vous recherchez le bk dans les expectorations par examen direct vous recherchez le bk dans les expectorations vous faites une culture vous recherchez le bk vous utilisez un test d'amplification génique qu'on appelle le genexpert soit vous faites des prélèvements histologiques à la recherche du granulome epithelioïdo giganto cellulaire je parle les moyens pour confirmer le diagnostic de tuberculose pulmonaire commune est ce que c'est l'intradermo est ce que c'est les recherches de bk dans l'examen direct de la culture le genexpert sur l'histologie à la recherche du granulome epithelioïdo giganto cellulaire comment vous confirmez le diagnostic de tuberculose commune donc par la recherche de bk à l'examen direct ou la coloration de zylinson pour voir la caractéristique alcool résistante acido alcool résistante qui apparaît sous forme rouge des bâtonnets rouges sur un fond bleu rechercher le bk sur la culture de milieu le van steyn johnson un milieu oeufs bilieux glyciné rechercher le bk par un test de genexpert c'est pas l'histologie c'est pas l'histologie c'est faux l'histologie le diagnostic de la tuberculose pulmonaire commune et les bactériologiques et les bactériologiques et les bactériologiques donc les réponses sont le b le c et le d le b le c et le d si vous devez choisir entre la méthode b c et d qu'il est la meilleure qui est la plus fiable qui est la gold standard les réponses b c d sont vrais mais moi je dis qu'est ce qu'on choisit sont entre ces c'est qu'elle est la meilleure en termes sensibilité spécificité est-ce que vous cherchez le bk à l'examen direct c'est la meilleure la culture c'est la meilleure le bk page expel c'est la meilleure est-ce que ce sont les avantages qui sont les inconvénients à votre avis le d recherche de bk par genexpert oui c recherche de bk par culture oui le c et le b aussi le b n'est pas le terme b non le b donc vraiment bravo la culture va prendre du temps beaucoup de temps on va pas attendre la culture pour traiter un malade ça demande la culture ce en quatre pratiquement quatre à deux semaines le d genexpert c'est quoi l'avantage du genexpert le genexpert il a un avantage et un inconvénient le

genexpert moi la réponse est juste que vous avez c'est pour discuter avec vous ça mais c'est pas là vous avez bien répondu sur la question et pour vous dire que les trois examens sont fiables que l'examen la recherche à l'examen direct c'est un examen rapide vous avez le résultat en 15 minutes et les traduits lorsqu'il est positif il traduit que votre malade est très contagieux mais parfois négatif n'élimine pas le diagnostic vous recherchez des bk à l'examen direct ou le tableau ce tableau radiologique vous avez vu c'est très évocateur de la tuberculose vous avez négatif ça n'élimine pas la ce n'élimine pas une tuberculose pour ce qui est la culture la culture c'est le gold standard c'est la gold standard c'est l'examen de référence mais le désavantage l'inconvénient ce qu'il va prendre du temps va prendre du temps pour donner les résultats vous recherchez la forme les colonies en choux fleurs il permet également d'identifier le bk et comment rechercher sa sensibilité aux médicaments et le troisième le gène expert c'est un test qui est rapide qui donnent des résultats dans 90 minutes pratiquement une heure trente et qui permet également de rechercher la résistance à l'arrivée en piscine à l'arrivée en piscine le problème du gène expert positif ça peut pas dire que c'est un bk vivant ou un bk mort parce qu'on peut avoir des bk vivants ou d'un bk mort mais en général c'est la culture là c'est le gold standard la culture sur le gold standard mettez trois ce sont des bonnes réponses ce sont les trois bonnes réponses si on dit culture négative s'il n'y a pas la tube c'est un diagnostic définitif pas de tuberculose si on vous dit j'ai un expert négatif positif ça peut être des bk mort si on vous dit le l'examen direct négatif ça n'élimine pas mais pratiquement ce vous devez retenir à votre stade à votre stade ce sont des informations supplémentaires mais à votre stade le diagnostic de la on a dit que le diagnostic de la primo infection et les immunologiques le diagnostic de la tuberculose pulmonaire commune et les bactériologiques donc les réponses b c et c ce sont les vraies réponses donc voici le granulome pour ce qui est du tuberculome le tuberculome le tuberculome c'est une forme pseudo tumorale rare exceptionnelle de la tuberculose donc c'est une forme clinique dans le cas de la tuberculose le tuberculome ce souvent on pense pas au diagnostic de tuberculome on pense à un cancer lorsque vous êtes devant une opacité ronde c'est souvent c'est une pratique évoque une tumeur et lorsqu'on fait l'histologie c'est dans l'optique de rechercher une tumeur et lorsqu'on enlève son module on trouve ce que du granulome le bk qui n'est pas négatif parce que le bk positif on le voit dans les cavernes les cavernes ce sont des lésions qui vont communiquer avec les branches et dans les branches il y a de l'air de l'oxygène donc à chaque fois il y a un entraînement de l'oxygène les bk vont se multiplier et par cette branche de drainage vont sortir pour le tuberculome c'est une forme particulière de tuberculose pulmonaire souvent le diagnostic du tuberculome se fait par l'histologie parce qu'on évoque surtout un problème myoplasique lorsqu'on fait le prélèvement et lorsque le bk il est encastré dans le granulome donc on n'aura pas les bk à l'examen direct les bk on les trouve à l'examen direct lorsqu'il y a la caverne lorsqu'il y a la caverne vous avez des bk à l'examen direct à la caverne dans le tuberculome vous n'avez pas de cavernes ce sont des nodules un aspect pseudo tumorale et son diagnostic se fait souvent à l'histologie parce qu'on cherchait un cancer plus que la tuberculose donc ce sont les éléments que vous devez retenir l'entradermo l'entradermo a une faible valeur vous avez une entradermo positif vous êtes étudiant en médecine vous avez un contact avec les malades si on vous fait

l'entradermo il est positif est-ce que vous avez la tuberculose maladie commune si on vous fait une entradermo si on va en entradermo vous avez je suis sûr qu'un pourcentage des gens qui sont passés dans des services de plus ou moins d'autres services on aura l'entradermo qui est positif est-ce qu'ils sont malades non est-ce qu'ils ont la tuberculose pulmonaire non ce qui se passe pour différencier entre la tuberculose infection la tuberculose c'est le premier contact alors que dans la tuberculose maladie c'est une modification des lésions qui sont au cours du premier infection c'est-à-dire au cours du premier infection le bk va être encerclé par le granulome et vous avez des bk dormants après lorsque le système immunitaire est défaillant vous avez une branche de drainage vous avez la branche de drainage va se drainer dans les branches dans les branches vous respirez de l'oxygène l'oxygène va entrer dans cette lésion et les bk ils bouffent l'oxygène pour avoir se multiplier ils ont de l'oxygène vous avez des bk qui se multiplient et la tuberculose qui était immunologique devient bactériologique donc lorsqu'on parle de la tuberculose maladie on part surtout de la bactérie c'est pas l'entradermo l'entradermo est peut-être positif c'est un élément d'orientation mais il ne permet pas de confirmer le diagnostic également une entradermo réaction négative n'élimine pas un diagnostic mais ce que vous devez retenir ce sont les éléments suivants la tuberculose pulmonaire commune est l'entité clinique la forme clinique la plus fréquente vous n'avez pas la primo infection vous n'avez pas trouvé beaucoup de tuberculose aiguë ce que vous trouvez dans pneumologie dans les services de physiologie c'est la tuberculose pulmonaire commune donc c'est la forme clinique la plus fréquente nous vous avons présenté un cas d'une pneumopathie non améliorée par une antibiothérapie donc devant une pneumopathie d'allure bactérienne non améliorée par une antibiothérapie vous pensez à la tuberculose pulmonaire commune et vous avez vu à la radiologie la caverne c'est l'aspect radiologique qui est évocateur et les bk sont souvent présents présents dans les sécrétions bronchiques c'est pourquoi vous avez répondu la diagnostic se fait par la bactériologie la recherche de bk à l'examen direct à la culture ou aux gènes experts ce sont les éléments que vous devez retenir si on vous parle de la tuberculose pulmonaire commune la forme la plus fréquente l'aspect radiologique l'évocateur c'est la caverne et les bk sont souvent présents dans l'imprimant à infection est-ce que les bk sont souvent présents dans l'imprimant à infection est-ce que les bk sont souvent présents si quelqu'un qui a l'imprimant à infection vous faites les bk est-ce que vous avez trouvé sont positifs ou négatifs est-ce qu'ils sont toujours négatifs est-ce que pendant l'imprimant à infection les bk sont toujours négatifs toujours il y a une situation où les bk peuvent être positifs dans l'imprimant à infection laquelle souvent dans l'imprimant à infection les bk sont négatifs mais il y a une situation particulière chez les enfants où la bk vous trouvez un bk qui est positif dans quelle situation si on revient au à l'imprimant à infection le complexe primaire il est formé par quoi le complexe primaire il est formé par quoi je vous rappelais de l'imprimant à infection le complexe primaire chancre et adénopathie et c'est des adénopathies lorsqu'ils se fustilisent dans les branches ces adénopathies contiennent des bk c'est la fustilisation gangliobronchique fustilisant souvent dans l'imprimant à infection tuberculose les bk sont négatifs et si vous avez un imprimant à infection sur un enfant surtout on dit que c'est l'imprimant à infection qui touche les enfants si vous trouvez les bk il faut chercher une fustule

gangliobronchique gangliobronchique donc la tuberculose pulmonaire qui est commune c'est une entité la plus fréquente évoquée devant une antibiothérapie une pleuropathie non améliorée par une antibiothérapie bien conduite la caverne et l'aspect radiologique évocateur et les bk sont souvent présents dans les sécrétions on va parler maintenant de tuberculose pulmonaire aiguë qu'est ce sont les tuberculose pulmonaire aiguë il y a trois la miliaire la pneumonie casseuse et la bronchopneumonie donc ce sont des entités rares ce sont des urgences thérapeutiques ils réalisent le tableau d'insuffisance respiratoire aiguë survient sur un terrain fragile son traitement est ce qu'il peut attendre la confirmation donc vous avez les tuberculose aiguë vous avez ça la miliaire lorsqu'on vous parle de tuberculose aiguë on parle trois entités la miliaire tuberculeuse la pneumonie casseuse de la bronchopneumonie qu'on appelle la physique galopante la physique galopante donc est-ce que c'est une entité rare ou fréquente la tuberculose aiguë est-ce que c'est une urgence thérapeutique on peut attendre après le traitement peut attendre rare oui c'est une pathologie rare oui c'est une urgence thérapeutique oui non on ne peut pas attendre donc son traitement ne peut pas attendre on ne va pas attendre la confirmation pour commencer un traitement souvent c'est dans la tuberculose aiguë l'intradermoréaction est négative parce qu'il survient sur un terrain fragile sur un terrain immunodéprimé vous avez cette image est-ce que c'est une vous avez des images ici des réticulations des micronodules des chevaux de champs pulmonaires est-ce que c'est une est-ce que c'est une pneumonie casseuse ou est-ce que c'est une bronchopneumonie cette image est-ce que c'est une image de milliard c'est une image de milliard des grains de mille des grains de mille des grains de mille milliard devant une milliard est-ce que vous réalisez un examen ophtalmologique est-ce que c'est utile ou non de réaliser devant une milliard un examen ophtalmologique examen ophtalmologique est-ce que il est utile n'est pas utile de réserve de faire un examen ophtalmo oui vous recherchez quoi si vous demandez un examen ophtalmo vous recherchez quoi je vous demandais un examen ophtalmo dans le cas de milliards vous demandez un examen ophtalmo vous recherchez quoi vous cherchez le tubercule corruydien de Beauchute et le tubercule corruydien de Beauchute traduit une dissémination méningée donc déjà méningée donc l'examen systématique à réaliser en cas de milliards c'est quoi l'examen à réaliser en cas de milliards tuberculose c'est quoi systématiquement vous devez réaliser cet examen c'est pas le fond d'oeil c'est pas la panction lambert la panction lambert rechercher des signes le tubercule de Beauchute vous pouvez faire examen ou non mais si vous le faites c'est la recherche de ce tubercule si vous le trouvez vous dites que c'est une dissémination méningée mais devant une miliaire tuberculose vous recherchez faites une panction lambert n'oubliez pas c'est un grand message c'est un message important pourquoi vous faites un panction lambert parce que la miliaire peut être soit localisée les suivants c'est une dissémination généralisée à d'autres organes et à d'autres viscères particulièrement au niveau méningée donc devant devant une tuberculose pulmonaire commune vous n'avez pas fait la panction lambert devant une primoire infection vous n'avez pas fait un lambert mais devant une miliaire tuberculose vous devez faire un lambert à la recherche d'une dissémination une autre localisation au niveau méningée donc c'est pourquoi on vous dit c'est une forme grave parce que c'est une forme peut-être d'autres organes donc ça c'est le tableau d'une pneumonie casseuse

pratiquement comme une pneumopathie ma question d'abord quelle est la différence entre une pneumonie bactérienne et une pneumonie d'origine la pneumonie casieuse c'est quoi la différence tout d'abord pour vous faciliter la réponse sur des données cliniques sur les données biologiques et sur les données radiologiques pour les autres formes pneumonie casieuse ou la bronchopneumonie non c'est la millière la millière c'est une dissémination c'est une dissémination par voie hématogène dans la pneumonie casieuse elle est sur ce localisé au niveau du poumon la bronchopneumonie c'est des branches pour moi les branches mais dans la millière il y a une dissémination par voie souvent hématogène c'est à dire le béca va passer dans le sang il va passer dans d'autres organes et particulièrement qu'on doit chercher c'est l'atteinte ménager parce qu'il a un facteur pronostic vital et un pronostic fonctionnel après donc si vous avez une pneumonie bactérienne et une pneumonie casieuse que soit la différence entre une pneumonie bactérienne et une pneumonie casieuse en répondant vous allez qu'est ce qu'il y a des signes cliniques il y a des signes biologiques il y a des signes radiologiques ou la réponse entre l'absence d'herpès labial dans la pneumonie bactérienne et la présence de l'herpès labial et dans la tuberculose il n'y a pas d'herpès labial bravo manel oui c'est une partie de réponse oui quoi d'autre le début il est progressif il y a des gens qui m'ont demandé une question j'ai dit que le début progressif il a dit non monsieur la tuberculose vous avez des tuberculoses aiguës donc vous devez avoir le début le début progressif c'est en comparaison en comparaison par rapport à la pneumonie bactérienne c'est en comparaison lorsque je vous dis est-ce que la pneumonie tuberculose est caractérisée par un début progressif c'est par rapport à la pneumonie bactérienne mais là sur ce forme de tuberculose c'est une tuberculose aiguë non améliorée par une antibiothérapie oui et quoi d'autre l'hyperlococytose plus important dans le cas de la tuberculose donc on va avoir ce tableau donc c'est ça ce tableau vous voyez ce tableau ça c'est la question ça c'est la réponse vous avez une question vous avez réponse sur le début il est progressif pour la pneumonie casieuse alors qu'il est aigu brutal dans la pneumonie bactérienne l'herpès labiale il est absent dans la pneumonie casieuse elle est présente dans la pneumonie bactérienne l'hyperlococytose elle est franche dans la pneumonie bactérienne elle est peu importante dans le cas de pneumonie casieuse les deux opacités vous voyez qui sont systématisées mais surtout la mauvaise évolution ce traitement antibiotérapie sur le cas de notre patient qui va vous évoquer une tuberculose ou là une tuberculose une pneumonie casieuse est-ce que vous avez des questions jusque là donc c'est bien si vous n'avez pas de questions je crois c'est c'est bien maintenant je vais essayer de faire tous les problèmes des questions facilement ne vous inquiétez pas c'est très facile on va parler des dilatations de branches les tumeurs médiastinales et de l'insuffisance mais c'est même c'est des cours trop chargés mais moi je vous donne des éléments les secrets les secrets des réponses donc on va essayer de parler de la dilatation des branches est-ce que c'est une maladie rare ou les fréquentes est-ce qu'il pose un problème de diagnostic avec la branchite chronique est-ce qu'il est évoqué devant une branquerie matinale peut-être acquise au congénital son diagnostic l'endoscopique et son traitement est surtout chirurgical on va essayer de répondre item par item est-ce que la dilatation de branches est une maladie rare est-ce qu'il est rare vous dites vrai ou faux vrai ou faux faux la dilatation de

branches sont des maladies fréquentes mais sont sous-estimées sont sous-estimées sous-diagnostiquées donc les dilatations de branches ce sont des maladies fréquentes c'est une maladie fréquente rare c'est faux est-ce qu'il pose le problème du diagnostic avec la bronchite chronique vrai ou faux vrai parce que on aura les dilatations de branches vous avez des expectorations quotidiennes également les gens qui fument les bronchites chroniques ont des expectorations matinales quotidiennes est-ce qu'il est évoqué devant une bronchite matinale lorsque vous entendez ce terme bronchite bronchite le premier diagnostic évoqué c'est la dilatation de branches bronchite matinale parce que vous entendez un terme de bronchite matinale parce que quelqu'un vous dit j'ai un patient qui a une bronchite matinale le premier diagnostic qui vous vient à la tête à l'esprit c'est la dilatation des branches les branches c'est quoi la différence entre une bronchite matinale et une simple expectoration c'est quoi la différence vous êtes ça c'est une bronchite matinale ça c'est une expectoration comment définir sans une bronchite matinale une bronchite la quantité il dépasse sans cesse quoi d'autre la bronchite il va se précipiter en plusieurs couches serreuse, muqueuse et mycopéruleuse vous avez l'expectoration il y a plusieurs couches donc la dilatation de branches c'est une maladie fréquente souvent un diagnostic différentiel avec les bronchites éhichroniques il est évoqué devant une bronchite matinale et parmi les étiologies des hémoptyses il y a les dilatations de branches pour ce qui est des étiologies est-ce qu'il est acquis ou congénital ou les deux il peut être acquis ou congénital donc il peut être acquis ou congénital nous avons deux groupes les étiologies acquises et les étiologies congénitales les étiologies acquises et congénitales le diagnostic est-ce qu'il est endoscopique par la fibroscopie est-ce que le diagnostic des dilatations de branches est endoscopique est-ce que le diagnostic est endoscopique si vous êtes faux c'est quoi parfois on fait un seul examen parfois on fait le diagnostic pas quoi les moyens diagnostiques ce qu'il est l'examen qui fait le diagnostic de dilatation des branches c'est l'imagerie l'imagerie et particulièrement la TDM c'est l'imagerie le diagnostic des dilatations là et les radiologiques le diagnostic de la dilatation de branches et les radiologiques le diagnostic des branches ectasées et les radiologiques radiologiques pour ce qui est du traitement est-ce qu'il est surtout chirurgical est-ce qu'il est surtout chirurgical vrai ou faux il est faux il est surtout médical et la chirurgie il est dans certaines situations mais surtout on se base sur un traitement préventif et un traitement de surinfection un traitement des complications vous voyez cette image de dilatation de branches ici des opacités qui stiquent aériolaires au niveau des deux bases vous le voyez au scanner les images qui stiquent vous avez on va chercher l'aspect en bagage à temps c'est à dire une branche avec une artère satellite ici l'artère la branche fait le double pratiquement de l'artère satellite normalement sont de même taille si on vous dit radio standard tdm ce qui est le meilleur qui fait le diagnostic de la dilatation des dilatations de branches est-ce que c'est la radio standard ou c'est le scanner c'est surtout le scanner une radio normale n'élimine pas le diagnostic radio normal n'élimine pas de dilatation de branches un scanner normal élimine le diagnostic de dilatation de branches donc le scanner c'est le gold standard le gold standard c'est l'examen de référence pour le diagnostic des dilatations des branches la radiographie peut être normale mais le scanner normal ça élimine le diagnostic de dilatation de branches donc on va

voir quel bilan vous allez réaliser dans le cas des dilatations des branches on va voir est-ce que vous allez réaliser un bilan une tdm une radio une bronchographie une fibroscopie une exploration fonctionnaire respiratoire est-ce que vous avez réalisé ça ou des examens que vous n'avez pas réalisé est-ce que si on vous demande vous réaliser tdm oui ou non dans le cas de dilatation des branches est-ce que c'est un examen utile la tdm oui la radiographie thoracique oui la bronchographie la bronchographie la bronchographie c'est un examen radiologique consistant à la pacification par un produit de contraste les branches est-ce que vous allez réaliser une bronchographie oui ou non non la bronchographie c'est un examen désuet qui n'est plus utilisé donc ce terme il faut l'oublier il faut l'oublier le diagnostic de dilatation de branches il est radiologique il est basé sur la radio standard et au meilleur sur la tdm thoracique est-ce que vous réalisez une fibroscopie bon j'étais pourquoi qu'il est l'intérêt de la fibroscopie dans le cas de des branches ectasy est-ce que vous réalisez une fibroscopie est-ce que c'était lorsque vous avez une pathologie à son branche est-ce qu'un jour vous faites une fibroscopie pourquoi vous faites la fibroscopie donc quel intérêt rechercher une étiologie oui rechercher une étiologie rechercher une cause un co-étranger c'est pas l'étiologie oui un cancer cancerisation vous avez une part de la réponse mais pour moi lorsque vous faites une une fibroscopie c'est surtout à viser microbiologiques à viser microbiologiques qu'est ce que la branquerie c'est une expectoration parfois il devient périllante donc vous faites une fibroscopie parce que vous cherchez des prélèvements microbiologiques surtout des prélèvements microbiologiques parce que la dilatation c'est une colonisation lorsqu'on parle de colonisation il y a des germes qui sont deviennent résistants parmi lesquels les pseudomonas lorsque vous faites une fibroscopie c'est tout d'abord localiser le siège de la supérotation faire des prélèvements microbiologiques également parfois vous avez de l'hémoptysie vous cherchez l'endroit au sein et en plus vous cherchez une cause locale favorisant les dilatations de branches mais surtout on fait la fibroscopie en cas de situation d'infection en cas de situation d'hémoptysie et dans le but également de rechercher une cause mais souvent c'est la fibroscopie à la recherche microbiologique parce que la dilatation de branches c'est une supérotation branchique chronique une supérotation branchique chronique le problème des branches hectazites c'est la colonisation par des germes résistants donc lorsque vous faites une fibroscopie la première chose c'est faire des prélèvements protégés et identifier des germes ou des colonisations également revoir la région où il y a la surinfection et parfois s'il y a un saignement localisé saignement et après voir l'état de la muqueuse comme l'a dit votre ami l'état de la muqueuse est-ce que vous avez trouvé un spéromètre normal, obstructif, restrictif ou mixte est-ce que vous avez trouvé un spéromètre normal, obstructif, restrictif ou mixte est-ce que vous avez trouvé un spéromètre normal, vous allez faire une spérométrie sur le malade qui a une dilatation de branches peut-être qu'ils vont être opérés peut-être non vous leur faire vous faire souffler pour évaluer l'importance des lésions et qu'est-ce que vous allez trouver est-ce que vous allez trouver de l'obstruction de la restriction ou les deux on peut trouver un syndrome obstructif oui souvent c'est un syndrome obstructif s'il y a une pleuropathie qui complique une dilatation peut avoir un syndrome restrictif mais en parlant on peut avoir obstructif et restrictif mixte on peut avoir restrictif, obstructif, restrictif, mixte le but de le faire c'est suivre l'évolution de la maladie

parce que les dilatations de branches ce sont des séquelles évolutives ce sont des lésions anciennes mais qu'on va évoluer le temps et qui va être évalué par l'évolution de la fonction respiratoire donc les examens utiles ce sont des examens radiologiques, des examens endoscopiques et des examens fonctionnels donc vous avez ces étiologies, les étiologies dyskinésie ciliaire, mycose os, déficit immunitaire, infection, reflux et pleurysie pérenne.

On va jouer c'est pas un jeu mais on va dire qui est congénital, qui, à qui, est-ce que la dyskinésie ciliaire fait partie des étiologies congénitales ou acquises vous répondez par c ou a. La dyskinésie ciliaire c'est congénital ou acquise c'est congénital oui la mycose os, la mycose os c'est congénital le déficit immunitaire, le déficit immunitaire c'est congénital ou acquis le déficit immunitaire est-ce qu'il est congénital ou acquis sans en laissant à part. Les infections respiratoires, les infections respiratoires ces étiologies acquises ou congénitales, les infections respiratoires c'est acquise ou congénital acquise, le reflux acquis, pleurysie pérenne, pleurysie pérenne c'est acquis donc dans les items il faut faire attention à ce déficit immunitaire. Si on veut dire congénital, vous le classez avec les étiologies congénitales, si on vous dit déficit immunitaire acquis fait partie des déficits, des étiologies acquises.

Donc nous avons la dyskinesie ciliaire, la mycose os c'est congénital, l'infection respiratoire, le reflux, pleurysie sont acquises et les déficits immunitaires se défendra selon l'énoncé. S'il est congénital on le classe avec le congénital, s'il est acquis on le classe avec les étiologies acquises. Quelles sont les complications d'hydratation de bronches? Les complications d'hydratation de bronches se compliquent par quoi? Le reflux est souvent délocalisé mais peut évoluer vers une atteinte diffuse.

Les atteintes diffuses se voient dans les formes congénitales. Donc l'étiologie hémoptysie, oui. Quoi d'autre? Les complications, insuffisance respiratoire chronique, oui.

Quoi d'autre? Les infections, les surinfections, oui. Quoi d'autre? La mylose, c'est pas le cancer, c'est pas le cancer, c'est faux. Le cancer c'est faux.

La supérotation c'est faux. La supérotation parce que c'est une définition. La dilatation de bronches c'est une supérotation chronique.

Donc les causes, c'est une surinfection, c'est une hémoptysie, c'est une insuffisance cardiaque, c'est une amylose, c'est une insuffisance respiratoire chronique. Il reste chez l'enfant. Chez l'enfant, dans quoi? Chez l'enfant.

Chez l'enfant. Chez l'enfant. Les abcès cerveaux, c'est des complications rares.

Chez l'enfant et dans quoi? Chez l'enfant. Chez l'enfant, un retard stadiopondéral. Maintenant, dites-moi, quelles sont les complications aiguës et quelles sont les complications chroniques? Des dilatations des branches, des complications aiguës, des complications chroniques.

On va passer l'hémoptysie. Est ce que c'est une complication aiguë chronique? Hémoptysie, complication aiguë ou chronique? Aiguë, bien, surinfection, surinfection. Aiguë, retard stadiopondéral, un retard stadiopondéral.

(1:09:55 - 1:10:37)

Un retard stadiopondéral est aiguë, chronique, chronique, insuffisance respiratoire, chronique, chronique, insuffisance cardiaque, insuffisance cardiaque, insuffisance cardiaque, chronique et la mylose, la mylose rénale, c'est aiguë, chronique, donc c'est chronique. Faut voir quelles sont les complications aiguës et les complications. En général, les complications de la dilatation de branches, c'est l'hémoptysie, les surinfections, le retard stadiopondéral sur l'enfant, l'insuffisance cardiaque droite, l'insuffisance respiratoire chronique et la mylose.

(1:10:37 - 1:11:01)

L'hémoptysie et les surinfections font partie des complications aiguës, des dilatations des branches. La mylose, la mylose, c'est des dépôts de substances fibrillaires d'origine protéique. Il y a des formes A, L et R, A, A. Toutes les infections chroniques, toutes les infections chroniques sont responsables de la mylose.

(1:11:02 - 1:11:09)

Ce n'est pas le mécanisme. Les étiologies des amyloses, ce sont les infections chroniques. Quelle que soit l'infection chronique, il va donner de la mylose.

(1:11:10 - 1:11:21)

L'infection dans quel organe, s'il est chronique, il va donner de la mylose. Ce n'est pas un mécanisme de relation entre les branches avec la mylose. C'est le problème de l'infection chronique qui donne de la mylose.

(1:11:23 - 1:11:33)

Donc, vous avez cette image là, c'est une image de kystidatque. On va essayer de vous répondre dans cinq minutes pour être rapide. Donc, vous avez cette image ronde en ballon de rugby.

(1:11:34 - 1:11:48)

Vous avez un ballon comme un ballon de rugby. C'est probablement un kystidatque sain. Donc, pour ce qui est des kystidatiques, il faut retenir ces éléments là, ces éléments là qu'il faut retenir.

(1:11:49 - 1:12:01)

Le kystidatque pulmonaire est une maladie parasitaire. Ce n'est pas bactérien, ce n'est pas virus,

ce n'est pas mycologique. C'est une maladie parasitaire.

(1:12:01 - 1:12:11)

Il y a un hôte définitif. Il y a un hôte intermédiaire et l'homme n'est pas définitif, c'est faux. C'est un hôte accidentel.

(1:12:12 - 1:12:22)

Donc, c'est une maladie parasitaire et l'homme, c'est la réponse, c'est la fausse. L'homme est un hôte accidentel. L'hôte définitif, c'est quoi? C'est le chien.

(1:12:22 - 1:12:35)

L'hôte définitif, c'est le chien. Le kystidatique pulmonaire, c'est la deuxième localisation chez l'adulte, alors qu'il est premier chez l'enfant. Le traitement du kystidatique, il est chirurgical.

(1:12:37 - 1:12:46)

La radiographie thoracique ne confirme pas le diagnostic. Elle permet de confirmer, ne confirme pas le diagnostic. La radiographie thoracique permet d'orienter.

(1:12:46 - 1:12:55)

Donc, si vous avez ces réponses-là, vous avez la réponse A qui est vraie. C'est une maladie parasitaire. L'homme est un hôte définitif et c'est faux.

(1:12:55 - 1:13:13)

Que l'homme est un hôte accidentel, que la deuxième localisation chez l'adulte, oui, c'est vrai. Son traitement du kystidatique, surtout chirurgical, et cette dernière, la radiographie thoracique, permet de confirmer le diagnostic. Non, à travers cette radio, on ne peut pas dire que c'est un kyst.

(1:13:13 - 1:13:22)

On dit que c'est une image ronde de telle ou telle taille, mais on ne dit pas que c'est un kystidatique. Donc, on va parler du chapitre. Souvent, c'est un kyst sain.

(1:13:23 - 1:13:40)

Souvent, c'est un kyst sain, il est asymptomatique. Mais on va, lorsqu'il est compliqué. Un kystidatique compliqué, est-ce qu'il est symptomatique ? Est-ce qu'il est souvent symptomatique ? Oui, un kystidatique compliqué, il est souvent symptomatique.

(1:13:41 - 1:14:02)

La deuxième chose, l'air succédant peut se voir, oui, parce qu'il y a des liquides idatiques, il est allergisant. Lorsqu'il est compliqué, il y a une issue de liquide à travers le kyst, il y aura des réactions d'hypersensibilité. Donc, l'air succédant, on peut avoir des lésions cutanées, des éruptions cutanées, en cas de kystidatique compliqué.

(1:14:03 - 1:14:17)

Et en cas de kystidatique sain, on ne va pas avoir de l'air succédant. En cas de kystidatique compliqué, on peut avoir une vomique, comme l'abcès, on va avoir une vomique. C'est pour cela qu'on va chercher la notion de vomique idatique si on veut être orienté par le diagnostic.

(1:14:18 - 1:14:31)

Et le kyst compliqué, souvent la sérologie, elle est positive. Sa sérologie, elle est souvent positive. Contrairement au kyst sain, parfois la sérologie peut être négative.

(1:14:31 - 1:15:00)

Et lorsque la sérologie est négative, ça n'élimine pas le diagnostic. Donc, dans le cas des premières images, on a vu cet aspect de kystidatique sain qui se consigne bien limité. Quels sont les aspects radiologiques d'un kystidatique compliqué ? Quel aspect radiologique vous avez vu dans un kyst compliqué ? La complication des kystidatiques, soit il est fissuré, soit il est rompu.

(1:15:01 - 1:15:35)

Dans le cas de kystidatique fissuré, quelle image vous allez voir ? Quel aspect radiologique vous allez voir au cas de kystidatique fissuré ? Au cas de kystidatique fissuré, vous allez quoi ? Fissuré, vous avez un aspect en, comme le ramadan, on cherche quoi ? Comme le ramadan, on cherche quoi ? L'image croissant, l'image de croissant ou de pneumoquiste. L'image de croissant, c'est la fissuration. L'aspect en croissant, ça traduit la fissuration.

(1:15:35 - 1:16:05)

Et au cas de kystidatique rompu, quel aspect vous allez voir ? L'aspect au kystidatique rompu. L'aspect du kystidatique rompu. Kystidatique rompu, quel aspect radiologique ? Aspect en pan et surtout aspect en nénuphar.

(1:16:05 - 1:16:22)

Aspect en nénuphar, en membrane flottante, oui. En membrane flottante, hydroaérique, en pan, ce sont les images qui sont très évocateurs d'un kystidatique rompu. Aspect en croissant au cas de kystidatique fissuré.

(1:16:25 - 1:16:37)

Vous allez voir quels sont les éléments qui orientent et quels sont les éléments qui confirment. L'orientation, c'est la notion de comptage avec les chiens. Vous évoquez un kystidatisme, toujours chercher l'interrogatoire.

(1:16:38 - 1:17:00)

Est-ce que votre patient a un contact avec les chiens ? Est-ce qu'il a de la profession ? Est-ce que c'est un boucher ? Est-ce que c'est un berger ? Et surtout rechercher la notion de vomique, au rejet. On a dit que l'aspect radiologique, l'aspect radiologique, c'est un élément d'orientation. Ce n'est pas de confirmation.

(1:17:01 - 1:17:15)

La radiologie oriente le diagnostic du kystidatisme, mais ne confirme pas le kystidatisme. Également, rechercher les autres localisations. Quelles autres localisations qu'on doit rechercher au cas du kystidatisme pulmonaire ? On a dit que c'est la deuxième localisation.

(1:17:15 - 1:17:38)

Quelle localisation on doit chercher si on suspecte un kystidatisme pulmonaire ? Quel organe qu'on doit chercher ? Il faut chercher s'il y a un kystidatisme associé. Un kystidatisme associé. Donc, pour voir que vous avez vraiment le diagnostic du kystidatisme, il faut voir si vous avez vu les membranes didactiques.

(1:17:38 - 1:17:52)

Est-ce que vous avez vu à l'examen ou au cours de la fibroscopie ? Le liquide didactique. C'est pourquoi on vous dit, devant une pleurésie, il ne faut pas ponctionner après avoir éliminé un kystidatisme. Parfois, vous faites une ponction, le kystidatisme vous a traumatisé.

(1:17:53 - 1:18:07)

On va rechercher les scolex. Donc, la sérologie, c'est un examen qui confirme le diagnostic. La sérologie didactique, peut-être quantitative ou qualitative, permet de confirmer le diagnostic.

(1:18:08 - 1:18:29)

Devant cette patiente, si la sérologie est positive, ça confirme le diagnostic. Mais est-ce que la sérologie peut être négative ? Si vous avez cette image, vous faites une sérologie trouvée positive, donc le problème est réglé. C'est un kystidatisme pulmonaire.

(1:18:29 - 1:18:53)

Mais avec cette image, vous avez la sérologie négative. Est-ce qu'il élimine le diagnostic ? Est-ce qu'une sérologie didactique négative élimine un diagnostic ? Est-ce qu'il élimine ? Il n'élimine pas

le diagnostic. Et parfois, on est obligé, avec cette image, avec une sérologie négative, de faire de la chirurgie.

(1:18:53 - 1:19:09)

Donc, on va découvrir le kystidatique à la chirurgie. Lorsqu'on le voit à la chirurgie, c'est évident, c'est le diagnostic de certitude. Donc, la chirurgie et la sérologie donnent le diagnostic de certitude, alors que l'imagerie donne un élément d'orientation.

(1:19:10 - 1:19:24)

Si on prend l'imagerie, c'est un élément d'orientation. La sérologie ou la chirurgie, ce sont des éléments pour confirmer le diagnostic de kystidatique. Donc, on va parler des tumeurs médiastinales rapidement.

(1:19:24 - 1:19:37)

Je vais tout rapidement. C'est un peu chargé, mais il faut se concentrer sur ce que je dis parce que les questions sortent de ce sujet pour un peu vous limiter la révision. Donc, vous avez une masse ici.

(1:19:37 - 1:20:00)

C'est une masse médiastinale. Quelles sont les caractéristiques d'une masse médiastinale ? Une masse médiastinale, si le contour externe est net, le contour, on peut la suivre, mais à l'intérieur, on ne peut pas la suivre. Donc, c'est un contour externe net et un contour internoyé dans le médiastin.

(1:20:00 - 1:20:36)

D'accord. Comment peut-on localiser cette tumeur ? Par quels moyens ? On peut dire, est-ce qu'il est antérieur, est-ce qu'il est postérieur ? Cette masse, par quels signes ? Par quels signes ? Pour dire, on voit que cette image est très visible au-delà de la clavicule. Est-ce qu'il est antérieur ou est-ce qu'il est postérieur ? Est-ce que cette image, est-ce qu'il est antérieur ou postérieur ? C'est un signe qu'on appelle le signe cervicotoracique.

(1:20:36 - 1:20:43)

Le signe cervicotoracique. Non, ce n'est pas le signe de la silhouette. Le signe de la silhouette, c'est avec le cœur.

(1:20:43 - 1:21:02)

Si vous effacez la silhouette du cœur, vous êtes antérieur. Si les deux opacités ont la même tonalité, si l'un efface l'autre, chacun est antérieur ou postérieur par rapport. Non, ça, c'est

postérieur.

(1:21:03 - 1:21:09)

C'est postérieur. Si celle-là disparaît, elle est silhouettée par le poumon. Donc, elle est antérieure.

(1:21:09 - 1:21:17)

Mais celle-là, elle reste visible. Parce que la radio, on le fait en postérieur et antérieur. Si vous faites en postérieur, ça reste visible.

(1:21:17 - 1:21:32)

Donc, c'est une postérieure. Ça, on l'appelle le signe cervicotoracique. Donc, pour caractériser une opacité, il y a le signe cervicotoracique, le signe de la silhouette, le signe de convergence des îles et le signe de l'aspect.

(1:21:32 - 1:21:42)

Je ne veux pas insister sur ça. C'est de la radiologie. Mais, moi, je veux dire, vous avez une masse médiastinale antérieure associée à myastinie.

(1:21:42 - 1:22:05)

Quelle diagnostic vous allez évoquer ? Un myastinie, ce sont des troubles neurologiques à des faiblesses musculaires, c'est-à-dire des anticorps atteints de la plaque motrice avec un anticorps anti-cholestérasique, un tumeur. Bravo, Imane. C'est tumeur.

(1:22:06 - 1:22:22)

Tumeur de médiastinale antérieure avec des signes neurologiques, le diagnostic à évoquer, c'est une masse chimique. C'est une tumeur chimique. Une masse médiastinale avec une myastinie.

(1:22:22 - 1:22:37)

Le premier crochet, c'est une tumeur chimique. Une tumeur médiastinale antérieure associée à une gynécomastie. Gynécomastie, c'est-à-dire les seins sur les hommes.

(1:22:38 - 1:22:55)

Les hommes qui ont des hypertrophies des glandes, des mamelons, on l'appelle une gynécomastie. C'est chez l'homme. Une masse médiastinale antérieure chez un jeune passant de 22 ans avec l'examen, une tumeur germinale.

(1:22:55 - 1:23:09)

Bravo, Khadija. Tumeur germinale. Une tumeur, masse médiastinale antérieure associée à une gynécomastie, tumeur germinale, et en particulier le choriocarcinome.

(1:23:10 - 1:23:24)

Le chorion, vous le voyez chez la femme enceinte, la grossesse, parce que c'est là qu'il se crée le bêta-ACG. Le bêta-ACG. Donc une masse médiastinale antérieure associée à une myastie.

(1:23:24 - 1:23:33)

C'est un tumeur humain. Une masse médiastinale antérieure associée à une gynécomastie. C'est un choriocarcinome, tumeur germinale.

(1:23:34 - 1:23:56)

Une masse du médecin postérieur, le cas de ce patient, associée à des tâches caféolées. À des tâches caféolées, à des signes cutanés. On a des signes neurologiques, des signes endocriniens, mais on a une masse médiastinale postérieure associée à des tâches caféolées.

(1:23:56 - 1:24:13)

C'est une tumeur nerveuse qu'on appelle le neurinome ou le neurofibrome. Il faut saisir ça. Devant un syndrome médiastinal, vous avez des compressions des organes qui sont de passage.

(1:24:13 - 1:24:36)

Vous avez des syndromes vasculaires, des syndromes respiratoires, des syndromes digestifs et des syndromes neurologiques. La compression, la paralysie des cordes vocales est l'expression d'une compression d'un nerf. Quel est ce nerf ? La paralysie des cordes vocales ou la dysphonie.

(1:24:37 - 1:25:00)

Quel nerf est comprimé ? La compression de la chaîne sympathique dans le syndrome de Claude-Bernard Horner et la compression du nerf phrénique va donner le hoquet ou la toux. Ça ne va pas donner la dysphonie. Ça va donner un hoquet.

(1:25:01 - 1:25:19)

Si vous comprimez le nerf phrénique, c'est un hoquet. Si vous comprimez le nerf récurrent gauche, c'est une paralysie des cordes vocales. Lorsqu'il y a des pneumo-gastriques, vous avez à ce moment-là une toux particulière.

(1:25:20 - 1:25:32)

Donc, on va parler du dernier chapitre. Ça sera rapide parce que c'est très compliqué, le chapitre d'insuffisance respiratoire. Je vous conseille de focaliser sur ces slides que j'ai passées.

(1:25:32 - 1:25:56)

Il ne faut pas trop charger votre cours, mais on va parler des éléments importants. Quels sont les mécanismes fissures pathologiques de l'insuffisance respiratoire ? Il y a pratiquement quatre mécanismes. Quels sont les mécanismes de l'insuffisance respiratoire ? Il y a l'hypoventilation.

(1:25:56 - 1:26:20)

Il y a l'hypoventilation. Il y a les anomalies de rapport de ventilation par fusion par lesquelles on sait qu'il y a l'effet Schendt, l'effet espace-mort ou l'effet Schendt-Bray ou le problème de diffusion. On ne va pas entrer dans les chapitres de mécanisme, mais nous avons cette situation clinique.

(1:26:21 - 1:27:04)

Patient âgé de 32 ans qui vient d'accoucher au troisième jour de postpartum présente un tableau d'insuffisance respiratoire. Quelle est l'étiologie la plus probable ? Une patiente de 22 ans qui vient d'accoucher et présente un tableau d'insuffisance respiratoire. Quelle est l'étiologie la plus probable ? Est-ce que c'est une pneumopathie, un pneumothorax, une exacerbation de PPSO ? Quel est le diagnostic ? Patient âgé qui vient d'accoucher et qui présente un tableau d'insuffisance.

(1:27:05 - 1:27:42)

Quelle est l'étiologie la plus probable ? Quelle est l'étiologie la plus probable ? Quelqu'un qui vient d'accoucher et présente un tableau d'insuffisance respiratoire. Quelle est l'étiologie la plus probable ? L'étiologie, ça peut être par enchymateuse, ça peut être bronchique, peut-être plurale, peut-être vasculaire. Donc, c'est quoi l'étiologie la plus probable ? Une patiente qui vient d'accoucher.

(1:27:43 - 1:28:03)

Qui dit accoucher, elle est comment la patiente ? Une patiente qui vient d'accoucher. Il est alité. Il y a des personnes alitées qui risquent encore d'avoir quoi ? Des gens qui sont alités après une chirurgie ou après un accouchement.

(1:28:04 - 1:28:16)

C'est l'embolie pulmonaire. C'est l'embolie pulmonaire. Patient où il y a l'alitement, c'est-à-dire il est alité au lit, il ne bouge pas, il a la stase, il a la thrombose.

(1:28:17 - 1:28:31)

C'est l'embolie pulmonaire. Si vous avez une situation de chirurgie lourde, d'accouchement, vous pensez à l'embolie pulmonaire. Les facteurs de risque de l'embolie pulmonaire, c'est l'alitement.

(1:28:31 - 1:28:53)

Ça peut être sûrement surtout dans le cadre de la chirurgie. C'est pour cela, dans les cas de l'accouchement ou dans le cas des chirurgies, il faut donner de l'héparine à visée prophylactique. Donc, lorsqu'on vous parle de chirurgie ou d'alitement, l'étiologie la plus fréquente, le premier diagnostic à évoquer, c'est une embolie pulmonaire.

(1:28:53 - 1:29:25)

J'insiste sur la chirurgie lourde ou la chirurgie en gros, par exemple, chirurgie du bassin ou chirurgie où quelqu'un qui présente une insuffisance ou un dyspnée, il faut en premier lieu évoquer un tableau d'embolie pulmonaire. Une cause d'insuffisance respiratoire, sa cause, elle est vasculaire. Avant de terminer rapidement, quels sont les signes cliniques d'hypercapnée ? Quels sont les signes cliniques d'hypercapnée ? Clinique d'hypercapnée.

(1:29:26 - 1:29:31)

Je vais vous citer, vous allez dire oui ou non. Cyanose. Cyanose.

(1:29:33 - 1:29:45)

Cyanose. Oui ou non ? Les signes d'hypercapnée. Cyanose.

Oui ou non ? Non. Cyanose, ça traduit l'hémoglobine réduite. Ça traduit l'hypoxymie.

(1:29:45 - 1:30:01)

La cyanose traduit l'hypoxymie. La cyanose traduit l'hypoxymie. Vous avez des vasodilatations cutanées, vasodilatations cutanées, est-ce que c'est un signe d'hypercapnée ? Oui.

(1:30:03 - 1:30:14)

L'hypotension, l'hypotension artérielle. L'hypotension artérielle. L'hypotension, est-ce que c'est un signe d'hypercapnée ? L'hypotension.

(1:30:15 - 1:30:30)

C'est l'hypertension artérielle. C'est l'hypertension, ce n'est pas l'hypotension, l'hypertension artérielle. Les astérisis, il y a des mouvements anormaux, anormaux des mains.

(1:30:30 - 1:30:58)

Est-ce qu'ils se voient dans l'hypercapnée, oui ou non ? Oui, l'astérisis, les mouvements anormaux, ça traduit l'hypercapnée. Un dernier mot, somnolence. Est-ce que la somnolence, tendance à s'endormir, c'est un signe d'hypercapnée ? Oui, la somnolence, la confusion, les troubles neurologiques, ce sont des signes de hypercapnée.

(1:30:59 - 1:31:16)

Donc j'espère, de toute façon, j'ai terminé, je crois que c'est terminé. J'espère que vous avez bien révisé et que les questions sont en secours, d'accord ? Je vous souhaite un ramadan kérîm, bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.

(1:31:17 - 1:31:19)

Je vous souhaite la réussite. Merci à vous.